



O caminho do coração

Apoio à decisão clínica em Cardiologia, para o cardiologista brasileiro

PROPOSTA DE PATROCÍNIO

Dr. Rafael Paes Meirelles

Cardiologista · CRM-SP 138266 · RQE 134798

Julho de 2026

01

De onde vem o nome

Corvia vem do latim. É a junção de cor, coração, com via, caminho. Lida inteira, a palavra diz o que o sistema faz: o caminho do coração — que é a assinatura da marca e também a descrição mais curta do que o sistema faz.

O NOME

Corvia — do latim cor (coração) + via (caminho). O caminho do coração.

Por que este nome, e não outro

A palavra tem dois sentidos que funcionam ao mesmo tempo, e é a sobreposição deles que sustenta o nome.

- **O caminho anatômico** — Cardiologia é feita de vias. A via de condução do estímulo elétrico, a via de saída do ventrículo, a via de acesso do cateter, a circulação como caminho fechado. Quem trabalha com o coração trabalha, o dia inteiro, com trajetos.
- **O caminho do raciocínio** — Nenhuma conduta cardiológica nasce pronta. Ela é o fim de um percurso. Da queixa leva ao exame, o exame ao escore, o escore à estratificação, a estratificação à conduta. É esse percurso que o sistema torna visível.

Há ainda um detalhe que a marca gráfica assume: as três últimas letras de Corvia formam IA. O acervo de inteligência artificial não é um acessório colado depois — está no nome, e responde sempre ao chamado no acervo verificado da própria plataforma, nunca de memória livre.

Como o nome bate com a função

Um sistema de apoio à decisão pode ser construído de duas maneiras. Pode entregar a resposta pronta: a dose, o corte, o nome do exame — e pedir confiança. Ou pode entregar o percurso inteiro, mostrando onde cada passo veio, e deixar a decisão com quem assina o prontuário.

A Corvia foi construída da segunda maneira, e o nome registra essa escolha. Por isso o fluxograma é uma árvore de decisão em que cada ramificação é uma pergunta clínica respondível à beira do leito. Por trás de cada afirmação carrega a diretriz e o ano que a sustentam. Por isso o que não está verificado aparece marcado como não verificado, em vez de sumir. O caminho é o produto.

LIMITE DECLARADO

A responsabilidade clínica é sempre de quem prescreve. A Corvia encurta o caminho até a informação correta e mostra a origem dela — não substitui julgamento clínico, e não foi desenhada para isso.

O problema que a Corvia resolve

O cardiologista brasileiro decide com pressão de tempo e com a informação espalhada. A diretriz responde à dúvida tem trezentas páginas e está num PDF. O escore está num site em inglês. A dose numa bula. A imagem de referência está num livro na estante do serviço. O ambulatório tem trinta minutos e a emergência não espera.

O que existe hoje, e por que não resolve

- **Resumo rápido sem fontes** responde em segundos e não permite conferir nada. Serve para lembrar, não para decidir, e quem o usa para decidir não tem como saber se o dado envelheceu.
- **Diretriz na íntegra** a fonte correta e é impraticável no meio do atendimento. Ninguém lê cento e vinte páginas entre dois pacientes.
- **Ferramenta internacional** — é escrita para outro sistema de saúde. Nem sempre considera a realidade de acesso, de disponibilidade de medicamento e de exame do Brasil.

A LACUNA

A lacuna é específica: profundidade de diretriz na velocidade de consulta, escrita em português, para o cardiologista brasileiro. É exatamente esse espaço que a Corvia ocupa.

Para quem é

Cardiologista, residente de Cardiologia e clínico que atende paciente cardiológico — enfermaria, emergência, ambulatório e consultório. O acesso é restrito a profissional habilitado, com registro e conselho verificado no cadastro. Não é um site de conteúdo de saúde para paciente, e não pretende

Como o conteúdo é feito

Esta é a parte do projeto que consome mais tempo e é a única que justifica a existência dele. Um de apoio à decisão sem procedência é pior que nenhum, porque transmite confiança sem entrega e fundamento.

A régua

Toda afirmação clínica precisa vir de diretriz vigente — ESC, AHA/ACC ou SBC — ou de estudo identificável. Referência completa e conferível, com DOI ou PMID quando existir. A régua é a de que um cardiologista citaria em discussão de caso.

Classificação de origem, documento por documento

Cada documento carrega o nível da fonte que o sustenta, derivado automaticamente das referências que ele cita:

Nível	O que significa	Acervo
A	Diretriz de sociedade ou estudo original, com identificador persistente (DOI ou PMID)	169 documentos
B	Fonte técnica idônea, sem identificador persistente — consenso, posicionamento, material de sociedade	79 documentos
C	Fonte fraca. Nenhum documento permanece neste nível: é condição de saída, não de permanência	0 documentos

O acervo começou com cinquenta e duas ocorrências de fonte fraca — material de estudante, sites, respostas geradas por inteligência artificial, calculadora de terceiro, material comercial de operadoras — e foram substituídas por fonte primária ou removidas. Hoje são zero.

Lacuna marcada, nunca escondida

Quando um dado não pôde ser confirmado numa fonte real, o campo não fica vazio nem recebe sinal de erro. Ele recebe a marca literal VERIFICAÇÃO HUMANA NECESSÁRIA, visível para quem lê.

POR QUE MARCAR EM VEZ DE OMITIR

A regra tem um motivo prático: um dado ausente sem marcação é indistinguível de um dado que ninguém procurou — e some da fila de revisão para sempre. Marcado, ele permanece na fila até alguém resolver.

Vigilância de diretriz desatualizada

Oitenta e seis diretrizes estão mapeadas no sistema, ligadas aos documentos que dependem delas.

Quando uma diretriz é substituída por versão nova, todos os documentos que a citam entram em revisão automaticamente. É o mecanismo que impede o acervo de envelhecer em silêncio, que é o mais comum de material clínico ficar errado sem que ninguém perceba.

O que a auditoria encontrou

Cerca de cinquenta e dois documentos passaram por auditoria linha a linha contra a fonte de dados encontrados aproximadamente vinte e quatro erros clinicamente relevantes, cinco deles com potencial dano direto ao paciente. Todos corrigidos. O tipo de erro importa mais que o número:

- **Número trocado** — O principal de ensaio clínico divergente do artigo original.
- Fonte apontando para o artigo errado do mesmo ensaio — o identificador resolvia normalmente outra publicação. Lição que virou regra: DOI que resolve não prova nada sobre o conteúdo.
- **Atribuição à diretriz errada** — Recomendação creditada a uma sociedade que não a emitiu.
- **Imagem descrita como o que não é** — de parede inferior rotulado como anterior.
- **Contradição entre tabelas** — mesmo índice com valor de corte diferente no verbete e no fluxograma. Este é o mais insidioso: só aparece quando alguém compara duas páginas, que é exatamente o que o assinante faz.

Imagem com licença conferida

Toda imagem da galeria vem de acervo de acesso aberto com licença verificável, com atribuição registrada. Nenhuma é gerada por inteligência artificial. As trinta e seis licenças foram conferidas uma por uma, e nenhuma tem cláusula que proíba uso comercial ou obra derivada — condição necessária para a plataforma por assinatura.

O que o sistema faz

Vinte e uma funções, organizadas por momento de uso — não por menu. A pergunta que separa é simples: o que o médico está fazendo quando abre a plataforma?

Decidir agora, com o paciente na frente

- **Fluxogramas clínicos** — dezesseis árvores de decisão em cardiologia aguda e crônica. Cada nó é uma pergunta respondível à beira do leito e cada folha é uma conduta. O formato é estrito: cada volta ou que converge é proibido, porque no meio de um atendimento um diagrama com laço não é consultável.
- **Calculadoras e escores** — escores validados com o cálculo feito na tela, corte de decisão explícito e fonte do corte visível junto do resultado.
- **Assistente clínico** — resposta em linguagem natural, ancorada no acervo verificado da própria plataforma e com os documentos de origem citados. Não responde de memória livre.
- **Busca** — pesquisa única sobre todo o acervo, tolerante a acento e a erro de digitação.

Consultar o acervo

- **Biblioteca científica** — quatrocentos e quarenta e nove documentos em vinte e sete temas, cobrindo a Cardiologia de ponta a ponta.
- **Medicamentos** — comparador com dose, apresentação, ajuste renal, contraindicação e interação em campo estruturado que permite comparar dois fármacos lado a lado.
- **Galeria de imagens** — trinta e seis achados de eletrocardiograma, ecocardiograma, tomografia, ressonância, radiografia e cateterismo, com laudo descritivo e licença registrada.
- **Exames** — dezessete exames e marcadores: o que mede, valor de referência, indicação, interpretação e limitação.
- **Evidências** — recomendações pontuais com classe, nível, sociedade e ano. Uma afirmação específica por registro, não o documento inteiro.
- **Estudos** — quinze ensaios clínicos e metanálises resumidos em texto próprio, com os números, desfecho e a implicação clínica.
- **Favoritos** — recorte pessoal de cada assinante sobre todo o acervo.

Trabalhar

- **Round hospitalar** — lista de pacientes internados com pendência e evolução, para a passagem de visita.
- **Agenda** — compromissos e retornos.
- **Modelos de documentos** — currículo, atestado e relatório, com cabeçalho que traz o nome e o registro do prescritor com peso visual maior que a marca. O documento é do médico, não da plataforma.
- **Checklist de alta** — três roteiros com trinta itens de verificação, para que nada essencial fique para trás na alta hospitalar.

- **Meus indicadores** que o próprio médico produziu no período.

Estudar

- **Trilhas de estudos** — trilhas com vinte e sete passos, em sequência pedagógica, com registro de progresso.
- **Cursos parceiros** — cursos de preparação para o Título de Especialista, oferecidos por parceiros assinados dentro da plataforma. O vídeo fica no ambiente do parceiro; o material de apoio aqui, por rota autenticada.

Serviço à distância

Laudo e consultoria de eletrocardiograma, MAPA, Holter e teste ergométrico, em regime eletivo. Preço calculado no servidor a partir do serviço e da urgência — nunca recebido do navegador, conta a partir da confirmação do pagamento.

DADO DE PACIENTE

O exame do paciente é cifrado em repouso com AES-256-GCM e guardado em volume sem endereço acessível de fora. O identificador do pedido entra como dado autenticado da cifra, de modo que um arquivo movido para outro pedido simplesmente não decifra. Toda leitura é registrada em log de auditoria.

Conta e assinatura

Perfil profissional com registro de conselho e RQE, foto validada por assinatura de arquivo, troca de histórico de faturas lido direto do provedor de pagamento e portal de autoatendimento para trocar ou cancelar. Cancelamento sem ligação, sem retenção forçada e sem formulário.

05

O acervo hoje

Números conferidos no banco de produção na data deste documento. Amplitude e profundidade s declarada do projeto: lacuna de cobertura é dívida do produto, não detalhe.

249	27	86	16
documentos científicos	temas	diretrizes mapeadas	fluxogramas

Frente	Publicado	Situação
Documentos científicos	227 de 249	22 em revisão final
Fluxogramas em árvore de decisão	16	no ar
Galeria de imagens	36	licenças conferidas uma a uma
Exames e marcadores	17	no ar
Evidências com classe e nível	19 de 20	1 aguardando conferência
Estudos e metanálises	15	identificadores conferidos
Calculadoras e escores	6	no ar
Checklists de alta	3 (30 itens)	no ar
Trilhas de estudo	3 (27 passos)	carregadas, a publicar
Medicamentos	100 cadastrados	em verificação contra bula

O QUE AINDA NÃO ESTÁ PRONTO

Medicamentos é a frente mais nova e a única ainda não publicada. Vinte e quatro registros carregam marca explícita de verificação pendente. Publicar antes de resolvê-las contrariaria a ré do projeto — então não foram publicados.

O que vem a seguir

- Fechar a verificação dos medicamentos contra bula aprovada e publicar a frente.
- **Ampliar os fluxogramas** — além, entre outros, regurgitação mitral, miocardite, amiloidose cardíaca, bradiarritmia e marcapasso, taquicardia de QRS largo, síndrome coronariana crônica, pericardite, cardiopatia congênita do adulto, cardio-oncologia, avaliação perioperatória e dislipidemia.
- Assinatura digital de documento com certificado ICP-Brasil, para que receita e laudo tenham validade legal fora da plataforma. Enquanto a credencial não sai, o sistema avisa explicitamente que o documento não está assinado — a etapa nunca é simulada.
- Estender a busca às frentes novas, que hoje só cobre os documentos.

06

Assinatura

Assinatura mensal individual, com acesso a todo o conteúdo — sem camada paga por cima, sem reservada a plano superior e sem cobrança por consulta ao assistente.

R\$ 20 por mês	1 plano único	0 taxa de adesão	0 fidelidade
--------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

- **Um plano só a**—decisão foi deliberada. Com um plano, não existe função escondida atrás de um nem tela de comparação de pacote.
- Cancelamento pelo próprio portal, a qualquer momento, sem ligação e sem retenção forçada.
- Serviço de laudo e consultoria à distância cobrado à parte, por pedido — não está incluído na assinatura e não a substitui.
- Curso parceiro assinado à parte, com preço próprio. Uma assinatura não substitui a outra, e is na tela antes da compra.

Independência

A Corvia é produto independente, sem vínculo institucional com hospital ou serviço. A responsabilidade clínica pelo conteúdo é do cardiologista responsável pelo projeto, nominalmente, e não de um coletivo anônimo.

07

Quem faz

A Corvia é idealizada, escrita e mantida por Rafael Paes Meirelles, cardiologista, CRM-SP 13826134798.

O conteúdo clínico não é terceirizado nem gerado sem conferência: cada documento passa por lei contra a fonte declarada antes de ir ao ar, e o que não passou fica marcado como pendente em vez de publicado assim mesmo. É por isso que uma parte do acervo aparece neste documento como não publicada — o número honesto é mais útil que o número redondo.

ONDE ENCONTRAR

corvia.med.br

Patrocínio

A assinatura é a receita principal e continuará sendo. O patrocínio existe para acelerar a produção de conteúdo — que é o que consome mais tempo e o que mais diferencia a plataforma —, não para substituir a assinatura nem para financiar o produto às custas de quem paga por ele.

Por que a Corvia é um canal legalmente habilitado

A RDC 96/2008 da ANVISA restringe a propaganda de medicamento sob prescrição a meios de comunicação dirigidos direta e unicamente a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar. É exatamente isso: acesso autenticado, cadastro com registro de conselho verificado, conteúdo exclusivamente técnico e nenhuma área aberta ao público leigo.

O ATIVO COMERCIAL

Isso torna a Corvia um dos poucos ambientes em que a divulgação técnica de medicamento sob prescrição é permitida — e a audiência é 100% prescritora e verificada, sem desperdício de alcance.

O que a norma exige, e que a plataforma vai exigir também

Os pontos abaixo são requisito de produto, não cláusula de contrato: estão especificados para virar uma peça de propaganda obrigatória na rota de cadastro do patrocinador — peça sem eles não é publicada. O modelo de patrocínio ainda não foi construído, e nenhum espaço comercial está no ar hoje; a especificação é feita antes do código de propósito, para que nenhuma peça seja publicada sob regra improvisada.

- **Contraindicação e interação obrigatórias** — a peça destaca benefício do medicamento, precisa exibir ao menos uma contraindicação e uma interação medicamentosa frequente, com o mesmo peso visual do benefício. A norma fala em impacto visual, e o componente respeita isso: não é em letra miúda.
- **Conteúdo limitado à bula aprovada** — de indicação fora do registro na ANVISA. Número de registro e princípio ativo são campos obrigatórios.
- **Vedações do art. 8º** — nada de anunciar o medicamento como novo, nada de estimular uso indiscriminado e nada de imagem de pessoa utilizando o produto.
- **Respaldo profissional identificado** — a peça cita profissional de saúde como referência, nome e número de inscrição no conselho são obrigatórios.
- **Rótulo mais forte** — a peça de medicamento é rotulada como Publicidade, não como Patrocinado, e o nome do registro de quem aprovou a peça e quando fica gravado.

Nota registrada em aberto: em agosto de 2024 o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em caso concreto, que a ANVISA extrapolou competência ao criar determinadas regras de propaganda. A decisão não invalida a norma, mas, um todo, e o desenho acima segue o texto vigente por opção conservadora. Contrato com laboratório deve passar por revisão jurídica antes de assinatura.

Categorias

Cinco cotas, todas abertas à indústria farmacêutica dentro das regras acima. Os valores são referência — leia a ressalva na página seguinte antes de tratá-los como preço.

Cota	Onde aparece	Faixa mensal
Fundadora institucional	Assinatura de apoio no rodapé de todas as telas, por assinatura própria de apresentação do patrocinador e menção na abertura das publicações do período. Exclusiva — uma por vez.	R\$ 2.500 a R\$ 4.000
Área	Vinculada a uma área clínica (arritmia, insuficiência cardíaca, dislipidemia, intervenção). Espaço identificado no rodapé das telas daquela área, sem entrar no corpo do conteúdo.	R\$ 800 a R\$ 1.500
Educação	Trilhas de estudo e cursos parceiros. Pode ser cota própria margem da revenda de curso, já implementada com repasse automático ao parceiro.	R\$ 200 a R\$ 2.500
Evento	Divulgação de congresso, simpósio ou curso, por determinado, em espaço de agenda e avisos.	R\$ 600 a R\$ 1.500 por evento
Diretório de serviços	Destaque de serviço de interesse do cardiologista clínica de imagem, serviço de hemodinâmica — em diretório declaradamente comercial e separado do acervo.	R\$ 300 a R\$ 600

Sobre os valores: o que a pesquisa achou e o que não achou

Não existe tabela pública de mídia para plataforma médica brasileira. A busca por referência devolve regulação — Resolução CFM 2.336/2023, manuais de publicidade médica — e materiais explicando modelos de cobrança por mil impressões. Nenhuma plataforma do setor publica pr

RESSALVA HONESTA

As faixas acima são estimativa fundamentada, não pesquisa de mercado, e estão apresentadas assim de propósito. Cobrança por mil impressões também não serve de âncora aqui: a base de assinantes ainda está em formação, e um número calculado sobre audiência pequena diria menos que o silêncio.

A âncora que faz sentido não é impressão: é a alternativa do próprio patrocinador. Um laboratório este espaço com estande em congresso, visita de propagandista e patrocínio de simpósio satélite que ele conhece e orça todo ano. A diferença é que aqui o contato é permanente, e não de três dias

Regras de execução

- **Identificação sempre** de espaço comercial é rotulado como Patrocinado, ou como Publicidade caso de medicamento. Nunca aparece com aparência de conteúdo editorial.
- **Espaço vazio desaparece** sem patrocinador, o bloco não fica como moldura vazia nem como convite. Ele simplesmente não é renderizado.
- **Número de terceiro exige fonte declarada** de cadastro recusa frase de destaque sem a fonte correspondente. Não é conferência manual: é validação de campo obrigatório.

O que não está à venda, em nenhuma cota

FORA DO COMÉRCIO

Resposta do assistente clínico. Conteúdo da biblioteca, fluxograma, evidência e estudo. Ordem de resultado de busca. Comparador de medicamentos. Checklist e trilha de estudo. Documento gerado pelo médico. E, acima de tudo, dado de assinante — que não é compartilhado, vendido nem usado para segmentar anúncio.

A razão é direta: no instante em que um patrocinador puder influenciar o que o assistente responde, a ordem em que um medicamento aparece no comparador, o produto deixa de ter valor clínico — e, portanto, deixa de ter valor comercial. A separação entre acervo e espaço pago é o que sustenta os dois.

Cláusula de revisão por base de assinantes

TEXTO PROPOSTO PARA CONTRATO

O valor vigente considera a base de assinantes na data da assinatura. A cada seis meses, ou quando a base ultrapassar 300, 1.000 e 3.000 assinantes ativos, o valor é renegociado, com o número informado ao patrocinador. Se a base não crescer conforme projetado, o patrocinador tem o direito a reduzir o valor ou encerrar sem multa.

A última frase é a que torna a cláusula bilateral, e é ela que permite negociar hoje, com a base atual em formação, sem prometer alcance que ainda não existe.